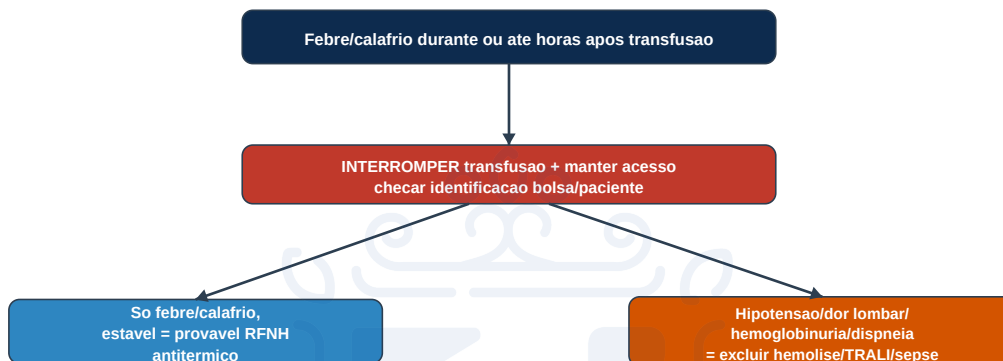


REAÇÃO TRANSFUSIONAL FEBRIL (RFNH)

FLUXOGRAMA — FEBRE DURANTE TRANSFUSÃO

RFNH — PRIMEIRO PASSO É SEMPRE PARAR



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Temperatura $\geq 38^\circ\text{C}$ COM aumento $> 1^\circ\text{C}$ em relação à temperatura pré-transfusional
- Associada à transfusão de hemocomponentes, na AUSÊNCIA de outras causas
- Mecanismo: anticorpos do receptor contra antígenos leucocitários/plaquetários do doador
- + liberação de citocinas acumuladas na bolsa durante a estocagem
- É a reação transfusional mais comum; geralmente benigna e autolimitada

QUANDO SUSPEITAR

QUADRO CLÍNICO E CONTEXTO

- Febre + tremor + calafrio + náusea/vômito
- Pode ocorrer no início, durante ou HORAS após o término da transfusão
- Tipicamente em pacientes POLITRANSFUNDIDOS (aloimunização prévia)
- Diagnóstico CLÍNICO e de EXCLUSÃO — sempre afastar causas graves antes
- Ausência de hipotensão, dor lombar, hemoglobinúria ou dispneia franca favorece RFNH

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL — NÃO CONFUNDIR

Reação	Pistas que a distinguem	Gravidade
RFNH	Só febre/calafrio, estável, sem hemólise	Benigna
Hemolítica aguda	Febre + dor lombar/no acesso, hipotensão, hemoglobinúria, ABO incompatível	GRAVE
Contaminação/sepsse	Febre alta, calafrio intenso, choque precoce, bolsa suspeita	GRAVE
TRALI	Dispneia + hipoxemia + infiltrado bilateral até 6h	GRAVE
Alérgica/anafilaxia	Urticária, broncoespasmo, hipotensão, SEM febre isolada	Leve a GRAVE

RED FLAGS — REAÇÃO GRAVE (NÃO É RFNH)

PENSAR EM CAUSA GRAVE SE

- Hipotensão, choque ou taquicardia desproporcional
- Dor lombar, dor no local do acesso, hemoglobinúria (urina escura) -> hemólise aguda
- Dispneia, hipoxemia, infiltrado pulmonar bilateral -> TRALI
- Febre muito alta com calafrios e deterioração rápida -> contaminação bacteriana/seps
- Nesses casos: NÃO reiniciar a bolsa, suporte agressivo e comunicar a agência transfusional

EXAMES — PARA EXCLUSÃO

QUANDO INVESTIGAR

- Reverificar identificação do paciente e da bolsa (erro ABO é a causa mais temida)
- Provas de hemólise: LDH, bilirrubina indireta, haptoglobina, Coombs direto
- Hemoglobina livre no plasma/urina (hemoglobinúria)
- Culturas (paciente + bolsa) se suspeita de contaminação
- Devolver a bolsa e o equipo à agência transfusional para reanálise

TRATAMENTO

Rx CONDUTA NA RFNH

1. INTERROMPER a transfusão imediatamente
2. Manter acesso venoso pérvio com soro fisiológico
3. Reverificar identificação bolsa x paciente
4. Antitérmico: Dipirona 1g IV OU Paracetamol VO
5. Sintomáticos conforme necessário (ex.: meperidina se calafrio intenso/tremor)
6. Monitorizar sinais vitais e reavaliar para excluir reação grave
7. Comunicar a agência transfusional e notificar o evento (hemovigilância)

PROFILAXIA

PREVENIR NOVOS EPISÓDIOS

- Indicada após 2o episódio leve OU após o 1o se grave
- Hemocomponentes DESLEUCOTIZADOS (filtrados) — medida mais eficaz
- Antitérmico pré-transfusional é controverso e não substitui a filtração
- Registrar a reação no prontuário e na ficha transfusional do paciente

CHECKLIST PÓS-EVENTO

ANTES DE LIBERAR / SEGUIR

- ☐ Reação grave excluída (estável, sem hemólise/dispnéia/hipotensão)
- ☐ Febre controlada com antitérmico
- ☐ Bolsa e equipo devolvidos à agência transfusional
- ☐ Evento notificado (hemovigilância) e registrado no prontuário
- ☐ Indicação de hemocomponente filtrado em transfusões futuras documentada

MODELO DE REGULAÇÃO / NOTIFICAÇÃO

RESUMO PARA HEMOVIGILÂNCIA

- Paciente em transfusão de ____ (CH/plaquetas), apresentou febre (____ C, elevação > 1 C) + calafrios.
- Transfusão interrompida; identificação bolsa/paciente conferida; reação grave excluída (sem hipotensão, dor lombar, hemoglobinúria, dispneia).
- Conduta: antitérmico/sintomáticos; bolsa e equipo devolvidos para reanálise.
- Hipótese: RFNH. Solicito desleucotização nas próximas transfusões e notifico o evento.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente politransfundido, 20 minutos após início de concentrado de hemácias, apresenta febre (38,5 C, elevação de 1,2 C) e calafrios, mantendo-se estável, sem dor lombar ou hipotensão. Primeira conduta?

- A) Acelerar a transfusão para terminar logo a bolsa
- B) Interromper a transfusão e manter o acesso com soro fisiológico
- C) Administrar adrenalina intramuscular
- D) Manter a transfusão e apenas dar antitérmico
- E) Iniciar antibiótico de amplo espectro de imediato

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado, durante febre transfusional, mais fortemente aponta para reação hemolítica aguda (e não RFNH)?

- A) Calafrio isolado
- B) Náusea leve
- C) Dor lombar com hipotensão e hemoglobinúria
- D) Febre que cede com dipirona
- E) Ocorrência em paciente politransfundido

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a medida profilática MAIS eficaz para prevenir recorrência de RFNH?

- A) Pré-medicação sempre com corticoide
- B) Transfundir mais rápido
- C) Usar hemocomponentes desleucotizados (filtrados)
- D) Aquecer a bolsa antes de infundir
- E) Reduzir o volume transfundido pela metade

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o diagnóstico da RFNH, é correto afirmar:

- A) É confirmado por teste sorológico específico
- B) É um diagnóstico clínico e de exclusão de outras causas de febre
- C) Exige biópsia de medula óssea
- D) Só pode ocorrer nas primeiras 24h após a transfusão
- E) É sempre acompanhado de hipotensão grave

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente transfundido evolui em 2h com dispneia, hipoxemia e infiltrado pulmonar bilateral, sem sinais de sobrecarga. A hipótese mais provável é:

- A) RFNH
- B) Reação alérgica leve
- C) TRALI (lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão)
- D) Contaminação bacteriana
- E) Reação hemolítica tardia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Diante de qualquer febre durante a transfusão, o primeiro passo é SEMPRE interromper a infusão e manter o acesso com SF, antes de classificar a reação. Só então se reverifica identificação e se exclui reação grave. Antitérmico vem depois.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Dor lombar + hipotensão + hemoglobinúria é a tríade que distingue a reação hemolítica aguda (frequentemente por incompatibilidade ABO) da RFNH, que é benigna e cursa apenas com febre/calafrio em paciente estável.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

A medida profilática mais eficaz é o uso de hemocomponentes desleucotizados (filtrados), reduzindo a carga de leucócitos e citocinas responsáveis pela RFNH. Pré-medicação antitérmica é controversa e não substitui a filtragem.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A RFNH é diagnóstico clínico e de exclusão: confirma-se afastando hemólise, contaminação, TRALI e reação alérgica. Não há teste confirmatório específico, e pode surgir até horas após o término da transfusão.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Dispneia + hipoxemia + infiltrado bilateral até 6h, sem sobrecarga volêmica, caracteriza TRALI — reação grave distinta da RFNH. Exige suporte respiratório e não reexposição ao hemocomponente do doador implicado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico